Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.

Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.

Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:

1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“ oder „unser Unternehmen“).

Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen. Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items zusammen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung. Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an. Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:

- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte Items, bis das Konstrukt 3 Items hat. Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in

den Quellen gibt, formuliere die Items neu. Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an. Markiere jedes übersetzte Item mit „(übersetzt)“. Markiere ein Item nur dann mit „(invers)“, wenn es in der Originalskala negativ formuliert ist. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

Ausgabeformat

Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel oder Ergänzungen hinzu.

Ausgabelänge

Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala entfällt.

Response:

1. Theorie und Begründung

In der vorliegenden Quelle (*Paper Fragebogen 1.pdf*: Wichmann et al., 2024) werden verschiedene etablierte Theorien aus den Bereichen Gesundheitswissenschaften, Informationssysteme und Psychologie aufgegriffen und miteinander verglichen:

1. **Health Belief Model (HBM)** (Hochbaum, 1958; Rosenstock, 1960, 1974)
    - *Passung zur Zielgröße:* Mäßig. Erklärt präventives Gesundheitsverhalten primär über die Wahrnehmung von gesundheitlichen Bedrohungen (Schwere und Verwundbarkeit) und Verhaltensbewertungen.
    - *Entscheidung & Begründung:* **Nicht als Einzeltheorie gewählt.** Das HBM blendet die spezifischen Eigenschaften und Akzeptanzfaktoren von modernen Informationstechnologien (z. B. KI-Systemen) weitgehend aus.
2. **Protection Motivation Theory (PMT)** (Rogers, 1975; Floyd et al., 2006)
    - *Passung zur Zielgröße:* Gut hinsichtlich des gesundheitlichen Bewältigungsprozesses (Dualitätsansatz aus Bedrohungs- und Bewältigungseinschätzung).
    - *Entscheidung & Begründung:* **Nicht als Einzeltheorie gewählt.** Die PMT erfasst zwar das Wechselspiel zwischen Krankheit und Behandlungsmaßnahme, vernachlässigt jedoch IT-spezifische Konstrukte wie Einstellungen zur Technologie oder wahrgenommene soziale Normen.
3. **Extended Parallel Process Model (EPPM)** (Witte, 1994, 2009)
    - *Passung zur Zielgröße:* Mäßig. Erweitert die PMT um Furchtkontroll- und Gefahrenkontrollprozesse.
    - *Entscheidung & Begründung:* **Nicht als Einzeltheorie gewählt.** Der Schwerpunkt liegt stark auf emotionalen Reaktionen (Furcht) bei Bedrohungen, während spezifische Prädikatoren der Technologieakzeptanz fehlen.
4. **Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / Technology Acceptance Model (TAM)** (Venkatesh et al., 2012; Davis, 1989)

    - *Passung zur Zielgröße:* Gut für rein technologische Aspekte der Systemnutzung.
    - *Entscheidung & Begründung:* **Nicht als Einzeltheorie gewählt.** Reine Technologieakzeptanzmodelle ignorieren den medizinischen Kontext und die Krankheitsbedrohung der Patientinnen und Patienten, die das Entscheidungsverhalten im Gesundheitswesen maßgeblich beeinflussen.
5. **Reasoned Action Approach (RAA) / Theory of Planned Behavior (TPB)** (Fishbein & Ajzen, 2011; Ajzen, 1991)
    - *Passung zur Zielgröße:* Mäßig bis gut bezüglich allgemeiner Verhaltensabsichten (Einstellung, wahrgenommene Normen, verhaltensbezogene Kontrolle).
    - *Entscheidung & Begründung:* **Nicht als Einzeltheorie gewählt.** Es handelt sich um ein allgemeines psychologisches Modell, dem die domänenspezifische Ausrichtung auf medizinische Behandlungen und KI-Systeme fehlt.
6. **Integriertes theoretisches Modell von Wichmann et al. (2024)** (*Duality Approach*)
    - *Passung zur Zielgröße:* **Optimal.** Dieses Modell kombiniert HBM, PMT, EPPM, UTAUT2 und RAA in einem interdisziplinären Ansatz. Es verbindet krankheitsbezogene Bewertungen (*nonadaptive appraisals*: wahrgenommene Bedrohung, Furcht vor der Krankheit, Einstellung zur Krankheit, nonadaptive Belohnungen) mit technologiebezogenen Bewertungen (*adaptive appraisals*: wahrgenommene Effizienz, Furcht vor dem System, Einstellung zum System, wahrgenommene Normen, Fähigkeiten und Kosten/Barrieren).
    - *Entscheidung & Begründung:* **Aufgenommen.** Das integrierte Modell von Wichmann et al. (2024) erklärt die Nutzungsabsicht KI-gestützter Gesundheitsinformationssysteme ganzheitlich und erreicht in den empirischen Szenarien der Quelle eine hohe Erklärungsleistung (R^2 zwischen 57,9 % und 81,7 %).

---

2. Modell mit Hypothesen

Aus dem integrierten theoretischen Modell von Wichmann et al. (2024, S. 6–7) werden die folgenden Hypothesen abgeleitet:

- **H1a:** Wahrgenommene Bedrohung → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 1a)
- **H1b:** Wahrgenommene Bedrohung → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 1b)
- **H2a:** Nonadaptive Belohnungen → Furcht (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 2a)
- **H2b:** Nonadaptive Belohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 2b)
- **H3:** Furcht (Krankheit) → Einstellung (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 3)
- **H4:** Einstellung (Krankheit) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 4)
- **H5a:** Wahrgenommene Effizienz → Furcht (HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 5a)

- **H5b:** Wahrgenommene Effizienz → Einstellung (HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 5b)
- **H5c:** Wahrgenommene Effizienz → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 5c)
- **H6:** Furcht (HIS) → Einstellung (HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 6)
- **H7:** Einstellung (HIS) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 7)
- **H8a:** Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohung (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8a)
- **H8b:** Wahrgenommene Normen → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8b)
- **H8c:** Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8c)
- **H8d:** Wahrgenommene Normen → Einstellung (HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8d)
- **H8e:** Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8e)
- **H8f:** Wahrgenommene Normen → Einstellung (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8f)
- **H8g:** Wahrgenommene Normen → Furcht (HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8g)
- **H8h:** Wahrgenommene Normen → Nonadaptive Belohnungen (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6 (Hypothesis 8h)
- **H9a:** Fähigkeiten (HIS) → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 9a)
- **H9b:** Fähigkeiten (HIS) → Furcht (HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 9b)
- **H9c:** Fähigkeiten (HIS) → Einstellung (HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 9c)
- **H9d:** Fähigkeiten (HIS) → Wahrgenommene Kosten/Barrieren (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 9d)
- **H9e:** Fähigkeiten (HIS) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 9e)
- **H10a:** Wahrgenommene Kosten/Barrieren (HIS) → Wahrgenommene Effizienz (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 10a)
- **H10b:** Wahrgenommene Kosten/Barrieren (HIS) → Einstellung (HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 10b)
- **H10c:** Wahrgenommene Kosten/Barrieren (HIS) → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 7 (Hypothesis 10c)

---

3. Liste der Konstrukte
    1. **Nutzungsabsicht** (*Intention to use*)
    2. **Einstellung gegenüber dem System** (*Attitude HIS*)
    3. **Wahrgenommene Wirksamkeit des Systems** (*Perceived response efficacy* – Dimension von Wahrgenommene Effizienz)
    4. **Wahrgenommene Verhaltenskontrolle** (*Perceived behavioral control* – Dimension von Wahrgenommene Effizienz)

5. **Furcht vor dem System** (*Fear HIS*)
6. **Wahrgenommene Normen** (*Perceived norms*)
7. **Wahrgenommene Verwundbarkeit** (*Perceived vulnerability* – Dimension von Wahrgenommene Bedrohung)
8. **Wahrgenommene Schwere** (*Perceived severity* – Dimension von Wahrgenommene Bedrohung)
9. **Nonadaptive Belohnungen** (*Nonadaptive rewards*)
10. **Furcht vor der Krankheit** (*Fear disease*)
11. **Einstellung gegenüber der Krankheit** (*Attitude disease*)
12. **Fähigkeiten bezüglich des Systems** (*Abilities HIS*)
13. **Wahrgenommene Kosten / Barrieren** (*Perceived costs / barriers HIS*)

---

4. Fragebogen

Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „stimme voll und ganz zu“)

Konstrukt	**Item**	**Quelle**
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung zu nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT1 (übersetzt)
Nutzungsabsicht	Ich plane, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT2 (übersetzt)
Nutzungsabsicht	Ich werde versuchen, bei meiner medizinischen Behandlung ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zu verwenden.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT3 (übersetzt)
Einstellung gegenüber dem System	Die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung halte ich für eine gute Idee.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS1 (übersetzt)
Einstellung gegenüber dem System	Die Verwendung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung finde ich klug.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS2 (übersetzt)
Einstellung gegenüber dem System	Ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung zu nutzen, beurteile ich als positiv.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS3 (übersetzt)
Einstellung gegenüber dem System	Ich finde die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung vorteilhaft.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS4

		(übersetzt)
Einstellung gegenüber dem System	Die Verwendung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung erscheint mir nützlich.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS5 (übersetzt)
Wahrgenommene Wirksamkeit des Systems	Ich glaube, dass ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem meine medizinische Behandlung wirksam verbessert.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item EFF1 (übersetzt)
Wahrgenommene Wirksamkeit des Systems	Ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem hilft mir effektiv dabei, meine Erkrankung zu bewältigen.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item EFF2 (übersetzt)
Wahrgenommene Wirksamkeit des Systems	Durch den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems wird der Erfolg meiner Behandlung erhöht.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item EFF3 (übersetzt)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich habe die vollständige Kontrolle darüber, ob ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung nutze.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC1 (übersetzt)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es liegt ganz bei mir, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung zu verwenden.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC2 (übersetzt)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich verfüge über die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, um ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zu nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC3 (übersetzt)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es fällt mir leicht, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC4 (übersetzt)
Furcht vor dem System	Der Gedanke an den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung macht mir Angst.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_HIS1 (übersetzt)
Furcht vor dem System	Ich fühle mich unruhig, wenn ich an die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems für meine Behandlung denke.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_HIS2

		(übersetzt)
Furcht vor dem System	Die Vorstellung, mit einem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem behandelt zu werden, beunruhigt mich.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_HIS3 (übersetzt)
Wahrgenommene Normen	Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung nutze.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item NORM1 (übersetzt)
Wahrgenommene Normen	Personen, deren Meinung ich schätze, würden es begrüßen, wenn ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem verwende.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item NORM2 (übersetzt)
Wahrgenommene Normen	Mein medizinisches Betreuungsumfeld befürwortet den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item NORM3 (übersetzt)
Wahrgenommene Normen	Die meisten Menschen in meinem Umfeld, die mir nahestehen, würden bei ihrer eigenen Behandlung ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item NORM4 (übersetzt)
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich halte mein persönliches Risiko, an einer behandlungsbedürftigen Erkrankung zu leiden, für hoch.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item VULN1 (übersetzt)
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Es ist wahrscheinlich, dass ich in der Zukunft von einer gesundheitlichen Verschlechterung betroffen bin.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item VULN2 (übersetzt)
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich fühle mich anfällig für gesundheitliche Einschränkungen, die eine medizinische Behandlung erfordern.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item VULN3 (übersetzt)
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Meine Chance, von gesundheitlichen Problemen verschont zu bleiben, ist gering.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item VULN4 (invers, übersetzt)
Wahrgenommene Schwere	Wenn ich an meiner Erkrankung leide, hat dies schwerwiegende Konsequenzen für mein Leben.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item SEV1 (übersetzt)
Wahrgenommene Schwere	Eine Verschlechterung meines Gesundheitszustands würde meinen Alltag erheblich beeinträchtigen.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item SEV2

		(übersetzt)
Wahrgenommene Schwere	Die gesundheitlichen Folgen meiner Erkrankung machen mir große Sorgen.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item SEV3 (übersetzt)
Wahrgenommene Schwere	Meine Erkrankung stellt eine ernsthafte Bedrohung für meine Lebensqualität dar.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item SEV4 (übersetzt)
Wahrgenommene Schwere	Komplikationen bei meiner Behandlung hätten gravierende Auswirkungen auf meine Gesundheit.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item SEV5 (übersetzt)
Nonadaptive Belohnungen	Wenn ich auf die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems verzichte, spare ich mir Aufwand.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item REW1 (übersetzt)
Nonadaptive Belohnungen	Es bringt mir Bequemlichkeit, meine bisherige Behandlungsart ohne ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem beizubehalten.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item REW2 (übersetzt)
Nonadaptive Belohnungen	Die Beibehaltung meiner gewohnten Behandlung ohne KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem gibt mir ein Gefühl von Vertrautheit.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item REW3 (übersetzt)
Furcht vor der Krankheit	Meine Erkrankung macht mir Angst.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_DIS1 (übersetzt)
Furcht vor der Krankheit	Ich empfinde Furcht, wenn ich an die möglichen gesundheitlichen Folgen meiner Erkrankung denke.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_DIS2 (übersetzt)
Furcht vor der Krankheit	Die gesundheitlichen Risiken meiner Erkrankung ängstigen mich.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEAR_DIS3 (übersetzt)
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich stehe meiner gesundheitlichen Situation aufmerksam gegenüber.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS1 (übersetzt)
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich betrachte den Umgang mit meiner Erkrankung als eine wichtige persönliche	Wichmann et al. (2024) / Fishbein &

	Aufgabe.	Ajzen (2011), Item ATT_DIS2 (übersetzt)
Einstellung gegenüber der Krankheit	Meine Einstellung gegenüber der aktiven Bewältigung meiner Erkrankung ist positiv.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS3 (übersetzt)
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich halte eine sorgfältige Auseinandersetzung mit meiner Erkrankung für notwendig.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS4 (übersetzt)
Einstellung gegenüber der Krankheit	Sich mit den Auswirkungen der eigenen Erkrankung zu befassen, finde ich sinnvoll.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS5 (übersetzt)
Fähigkeiten bezüglich des Systems	Ich traue mir zu, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung zu verstehen.	neu formuliert
Fähigkeiten bezüglich des Systems	Ich besitze die Fähigkeiten, mit einem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem umzugehen.	neu formuliert
Fähigkeiten bezüglich des Systems	Es fällt mir leicht, die Funktionsweise eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems nachzuvollziehen.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten / Barrieren	Der Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist für mich mit hohem Aufwand verbunden.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten / Barrieren	Ich sehe große Hürden bei der Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems für meine Behandlung.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten / Barrieren	Die Verwendung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bringt für mich erhebliche Unannehmlichkeiten mit sich.	neu formuliert